

CAPÍTULO 8.4

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

PERFIL EUNACOM 1.06.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII)**, que incluyen la **Colitis Ulcerosa (CU)** y la **Enfermedad de Crohn (EC)**, son patologías crónicas de etiología autoinmune. Se caracterizan por presentar un curso clínico con brotes de actividad y periodos de remisión, afectando predominantemente a adolescentes y adultos jóvenes.

Generalidades y Clínica Común

Ambas entidades comparten un núcleo de síntomas cardinales debido al estado inflamatorio sistémico e intestinal:

- **Diarrea crónica:** Generalmente de tipo **disentérica** (con sangre, mucosidad o pus).
- **Dolor abdominal:** Habitualmente de tipo cólico, aunque puede ser persistente.
- **Sintomatología sistémica:** Baja de peso, fiebre y compromiso del estado general (estado hipercatabólico).
- **Edad de inicio:** Típicamente en el adulto joven.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología es **autoinmune**. Existe una desregulación de la respuesta inmune contra la microbiota intestinal en individuos genéticamente predispuestos, lo que genera una inflamación crónica de la pared intestinal.

Manifestaciones Extraintestinales

Las EII no se limitan al tubo digestivo; al ser procesos autoinmunes, pueden afectar múltiples sistemas:

- **Articulares (lo más frecuente):**
 - **Artritis periférica.**
 - **Espondilitis Anquilosante** (afectación axial).
- **Oculares: Uveítis anterior.**
- **Dermatológicas:**
 - **Eritema nodoso** (nódulos dolorosos en extremidades).
 - **Pioderma gangrenoso** (úlceras cutáneas profundas y graves).
- **Hepatobiliares:** Colangitis Esclerosante Primaria (más asociada a CU).

Diagnóstico Diferencial: Colitis Ulcerosa vs. Enfermedad de Crohn

El estudio de elección para ambas es la **colonoscopia con toma de biopsia**. Este examen permite no solo confirmar la enfermedad, sino diferenciar ambas entidades según su distribución y profundidad.

TABLA 8.4.1: CARACTERÍSTICA VS COLITIS ULCEROSA (CU)

CARACTERÍSTICA	COLITIS ULCEROSA (CU)	ENFERMEDAD DE CROHN (EC)
Ubicación	Solo el colon. Siempre inicia en el recto.	Todo el tubo digestivo (boca a ano).
Distribución	Continua (sin áreas sanas intermedias).	En parches ("Skip lesions").
Profundidad	Limitada a la mucosa .	Transmural (toda la pared).
Compromiso Rectal	100% de los casos (Rectitis).	Puede respetar el recto.
Intestino Delgado	Nunca afectado.	Frecuentemente afectado (Íleon distal).
Anticuerpos	p-ANCA (+)	ASCA (+)
Hallazgos clínicos únicos	Pujo y tenesmo intensos.	Masas abdominales, úlceras orales.
Complicaciones	Megacolon tóxico, Cáncer.	Fístulas, abscesos, obstrucción.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro para el EUNACOM: Basta que el paciente presente **una sola característica propia del Crohn** (ej. afectación de íleon, fístulas, compromiso perianal o parches) para que el diagnóstico sea Enfermedad de Crohn. Si es continuo y solo colónico, es Colitis Ulcerosa.

Complicaciones Específicas

Debido a la naturaleza de la inflamación, las complicaciones varían drásticamente:

- **Enfermedad de Crohn:** Al ser una inflamación **transmural**, es característica la formación de:
 - **Fístulas** (comunicación entre el intestino y otros órganos o la piel).
 - **Abscesos perianales.**
 - **Obstrucción intestinal** por estenosis cicatriciales.
 - **Síndrome de Malabsorción** (por compromiso del intestino delgado).
- **Colitis Ulcerosa:**
 - **Cáncer de Colon y Recto:** Existe un riesgo aumentado tras 8-10 años de evolución, lo que obliga a colonoscopías de screening frecuentes.
 - **Megacolon tóxico:** Dilatación extrema del colon que constituye una urgencia vital.

Tratamiento

El manejo clínico es similar en cuanto a fármacos, buscando inducir y mantener la remisión.

Manejo Farmacológico

1. **Antibióticos:** De amplio espectro (útiles en brotes y complicaciones como abscesos). 2. **Antiinflamatorios (5-ASA):** Mesalazina o Sulfasalazina (especialmente en CU). 3. **Corticoides:** Budesonida o Prednisona para el manejo del brote agudo. 4. **Inmunomoduladores:** Azatioprina, Metotrexato. 5. **Terapia Biológica: Infliximab** (anticuerpo anti-TNF alfa). Es altamente eficaz y con pocos efectos adversos, aunque de alto costo.

Manejo Quirúrgico

La cirugía es el último escalón terapéutico (falla de tratamiento médico o complicaciones).

- **En la Colitis Ulcerosa:** La **colectomía** (extirpación del colon) es **curativa**, ya que la enfermedad se limita a este órgano. Se puede realizar una colectomía subtotal (manteniendo el recto) o total (con ileostomía definitiva si hay cáncer o displasia rectal).
- **En la Enfermedad de Crohn:** La cirugía **NO es curativa**. Solo se realiza resección del segmento comprometido y anastomosis primaria. La enfermedad puede reaparecer en cualquier otra parte del tubo digestivo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca indiques una colectomía total en un paciente con Crohn pensando que lo vas a curar; la enfermedad es sistémica y puede afectar desde la boca hasta el ano.

Perlas Clínicas y Casos EUNACOM

- **Caso 1:** Paciente de 68 años con baja de peso, diarrea sanguinolenta y masa abdominal.
- - *Sospecha:* **Cáncer de Colon**. (Por la edad, siempre descartar neoplasia primero).
- **Caso 2:** Paciente de 28 años con baja de peso, diarrea sanguinolenta y masa abdominal.
- - *Sospecha:* **Enfermedad de Crohn**. (La masa abdominal sugiere inflamación transmural/plastrón en un paciente joven).
- **Caso 3:** Paciente joven con pujo y tenesmo rectal de 2 semanas, seguido de diarrea disintérica.
- - *Sospecha:* **Colitis Ulcerosa**. (Inicia como rectitis y progresa proximalmente de forma continua).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante cualquier sospecha de EII o Cáncer de Colon en el examen, la conducta inicial siempre es solicitar una **Colonoscopia**.

Temas relacionados: **Diarrea Crónica, Cáncer de Colon, Artritis Reactiva.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 24 años consulta por diarrea con mucosidad y rectorragia de 3 meses de evolución (4-6 deposiciones al día) asociada a pujo, tenesmo y dolor en fosa ilíaca izquierda. Colonoscopia revela eritema difuso continuo, friabilidad de la mucosa con sangrado fácil y pérdida del patrón vascular desde el margen anal hasta el ángulo esplénico."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Colitis Ulcerosa (CU): enfermedad inflamatoria intestinal caracterizada por inflamación CONTINUA y limitada a la MUCOSA, originada siempre en el recto con extensión proximal. Anticuerpos p-ANCA positivos (a diferencia de Crohn, que es transmural, parcheada y ASCA +). Tratamiento de inducción y mantención en brote leve-moderado: Mesalazina oral + tópica (supositorios/enemas). En brote severo: Corticoides sistémicos EV (Hidrocortisona) e inmunomoduladores/biológicos (Anti-TNF).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- EII son autoinmunes, afectan jóvenes, producen diarrea disintérica crónica con fiebre y baja de peso
- Colitis ulcerosa: siempre afecta recto, inflamación continua, solo colon, mucosa, ANCA+
- Crohn: puede respetar recto, en parches, todo el tubo digestivo, transmural, ASCA+, fístulas/obstrucción/perforación
- Manifestaciones extraintestinales: artritis periférica (más frecuente), espondilitis, uveítis, eritema nodoso
- Basta una característica de Crohn para diagnosticarlo; sin características de Crohn = colitis ulcerosa
- Tratamiento: corticoides, inmunomoduladores, 5-ASA, antibióticos, infliximab; última línea cirugía
- Cirugía de colitis ulcerosa: colectomía (curativa); Crohn: resección segmentaria
- Colitis ulcerosa se asocia a cáncer de recto

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL)

PREGUNTA 1

Paciente de 25 años con diarrea disintérica de 3 meses de evolución, baja de peso, fiebre y masa palpable en fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Colitis ulcerosa
- B) Enfermedad de Crohn
- C) Cáncer de colon
- D) Apendicitis aguda
- E) Tuberculosis intestinal

PREGUNTA 2

Mujer de 22 años consulta por pujo y tenesmo de 2 semanas de evolución, luego de lo cual aparece diarrea con sangre y mucosidad. La colonoscopia muestra inflamación continua desde el recto hasta el colon sigmoides. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Enfermedad de Crohn
- B) Colitis ulcerosa
- C) Colitis infecciosa
- D) Cáncer de recto
- E) Síndrome de intestino irritable

PREGUNTA 3

En un paciente con colitis ulcerosa refractaria a tratamiento médico, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico indicado?

- A) Resección segmentaria del colon comprometido
- B) Colectomía subtotal
- C) Ileostomía de derivación
- D) Anastomosis ileorrectal sin resección
- E) Colostomía proximal

RESUMEN: ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Ambas son autoinmunes, afectan a personas jóvenes, producen diarrea crónica disintérica con dolor abdominal, baja de peso y fiebre, y pueden tener manifestaciones extraintestinales (artritis periférica, espondilitis, uveítis, eritema nodoso). Las diferencias clave: la colitis ulcerosa siempre afecta el recto, tiene inflamación continua, se limita al colon, afecta solo mucosa (ANCA+). El Crohn puede respetar el recto, inflamación en parches, afecta todo el tubo digestivo incluido intestino delgado, es transmural (ASCA+), y se complica con fístulas, obstrucción y perforación. El tratamiento incluye antibióticos, sulfas, 5-ASA, corticoides, inmunomoduladores e infliximab. La cirugía difiere: colitis ulcerosa se trata con colectomía (curativa), mientras que el Crohn solo con resección segmentaria del segmento comprometido.